

إسم المريض رباعياً : نوره حمدي عثمان السيد
المحافظة : الفيوم الحي / المدينة : اطسا
رقم البطاقة : 27907152300601 رقم التليفون : 01026286042
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-07-1979 المهنة : ربه منزل
العنوان : .
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 جهة العلاج :
 نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نوره حمدي عثمان السيد National ID: 27907152300601	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

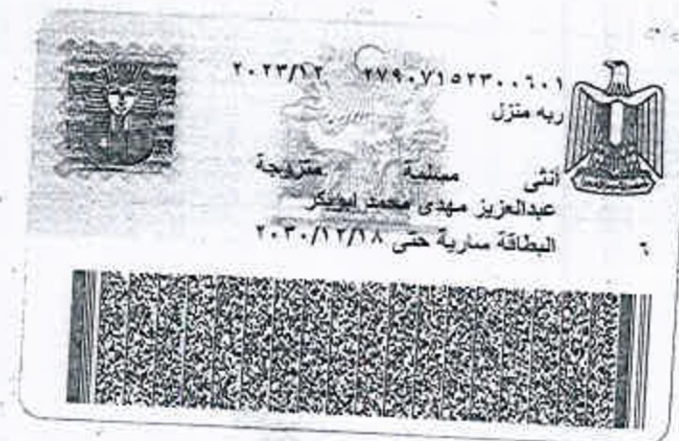
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين









مجلس إدارة رئيس الجمهورية
لجنة صحت المرأة المصرية

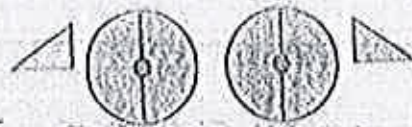
הוצאת ספרים
מגן

MDT FORM

5/12/2022 G

Clinical Data

Sonomammography:



TNM₀
461^o

Mets Workup:

Recommendations: Referred 4AC → 3 Exposed → PR → 1st MEY
12/21

→ last follow up 2y

Control: vaginal bleeding
Colaptes presens

SVVS
CTCAP → (R)
MHC → asked the pathology lab
abs → (R) pc → JTB

MDT OUTCOME & PLAN. 13 - 12 - 2022

Go Not Alone (Meadow)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>[Signature]</i>		<i>ES. Umrigar</i> <i>young</i> <i>Chittell</i>			

Angelsk
13/12/2018

Pathology Report

Name: نوره حدى عثمان

Age: 37 years.

Clinical data: Left breast mass & axillary lymph nodes.

Specimen type: Tru-cut biopsy.

Date: 16/7/2020

Lab. Number: 1012

Hospital Number: 2504/2020

Gross Description:

Two specimens were received:

- 1) Left breast Mass; multiple greyish white tissue cores, the longest was; 1.3 cm, totally submitted.
- 2) Axillary lymph nodes; multiple greyish white tissue cores, the longest was; 1.3 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared from specimen 1 reveled an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are marked [grade III].

Specimen 2 revealed malignant growth infiltrate with the same picture of specimen 1.

Diagnosis:

Left breast mass & axillary lymph nodes;

- 1) Invasive duct carcinoma GIII.
- 2) Metastatic invasive duct carcinoma in axillary tissue core.
- 3) The case for IHC (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Gamal Abdel-Aziz

Prof. Dr. Essam Ayad



الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
مركز الأورام والدم
أوراق العمل
لشعب الأمراض

Pathology Report

Name: نوره خدي جنان

Age: 37 years.

Clinical data: Left breast mass & axillary lymph nodes.

Specimen type: Tru-cut biopsy.

Date: 16/7/2020

Lab. Number: 1012

Hospital Number: 2504/2020

Gross Description:

Two specimens were received.

1) Left breast Mass; multiple greyish white tissue cores, the longest was; 1.3 cm, totally submitted.

2) Axillary lymph nodes; multiple greyish white tissue cores, the longest was; 1.3 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared from specimen 1 revealed an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are marked [grade III].

Specimen 2 revealed malignant growth infiltrate with the same picture of specimen 1.

Diagnosis:

Left breast mass & axillary lymph nodes;

- 1) Invasive duct carcinoma GIII.
- 2) Metastatic invasive duct carcinoma in axillary tissue core.
- 3) The case for IHC (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Gamal Abdel-Aly

Prof. Dr. Essam Ayad



Ministry of Health
Clinical Health Laboratories
Pathology Department

Immunohistochemistry report

Report Number: m3838

Female	المرأة	تاريخ أخذ العينات	41 Y
21/07/2020 08.30	تاريخ الاستلام	تاريخ الفحص	
28/07/2020 10.42	تاريخ التقرير	مركز فحص العينات	

Primary Sample

Primary Block

351

HER2 & HER2 neu 3 K57 (ER&PR, Harvey scoring system, Her2neu, QAP scoring system)

Comment

Technique

Sample received was treated by: CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody + C-11-16 1%
+ cytoplasmic receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody
Sample received was treated by: AVENTANA anti-HER2 neu (495) Rabbit monoclonal primary antibody using QAP (1:1000)
+ 1% vascular benchmark GX
Sample received was treated by: CONFIRM anti-K57 (39-9) Rabbit monoclonal primary antibody

Result

ER: weak nuclear staining of 10% of tumour cells
PR: weak nuclear staining of 1% of tumour cells
HER2: strong, over expression, moderate continuous membrane staining of + 10% of tumour cells
K57: positive nuclear staining of about 70-80% of tumour cells

Referral Lab

Comment

Conclusion

ER: POSITIVE (SCORE 5-8)
PR: POSITIVE (SCORE 3-8)
HER2: PROTEIN OVEREXPRESSION - EQUIVOCAL (SCORE 2+)
K57: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 70-80%
DOSE BIOPSY

Pathologist

Lab Director

11, El-Dokki, Helwan Street, Andeen, Cairo
Tel: 02 44550700 Fax: 02 44550711
Email: 02 44550712
Website: www.moh.gov.eg
Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia

KLAC LAB REPORTS SENT BY (QAP) - Harvey 1-4-5

Pathologist